

acompanhamento () consulta

NS: 22232881617 | 183

EDEGARD DE SÁ AMORIM

IDADE: 84 a PESO: 90 ALTURA: 183 PROFISSÃO: lantador - Apos

SINTOMAS: Boca seca

QUEIXAS: sonolência (diurna) / Pernas pesadas /

MEDICAMENTOS: Valeriane

MÉDICO: Drº Alberto

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x musculação

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (20)

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7hrs

COCHILLO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO F.S.

FUMO ☒ SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: (1975 parou)

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 52 e/ev SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite / Dengue há 1m

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA Turbonectomia Denário septo

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não Intolerância lactose

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS hernia discal cervical

12/06 Avaliação (retornou o uso do CPAP)

20/06/24 P= 6,6 cmH₂O

IAH= 4,2 e/ev

m. de uso: 6h27m

Bem adaptado

Natacha

16/10/2024 P= 6,5 cmH₂O

IAH= 4,4 e/ev

m uso: 5h34'

Auto 6 à 8 cmH₂O

relata sono diurna

sugiro dormir mais horas

Silvia

13/11/24

P= 6,4 cmH₂O

P90% 7,5 cmH₂O

IAH= 5,0 e/ev

m uso= 6h50min

fuga=

↑ Auto 6 à 8,5 cmH₂O

Silvia

11/12

P= 6,4 cmH₂O

Perc. 7,7 cmH₂O

IAH= 4,2 e/ev

m. de uso: 6h20'

Relata alívio a boca

fuga= 2'

Jos

10/04

Trouxe CPAP

pelo

Autotext 510.

25

Nome: **EDEGARD DE SA AMORIM**

Sexo: **M**

Idade: **76 anos**

Exame nº: **17506432**

Peso: **94 Kg**

Altura: **1,78 m**

Data: **27/08/2016**

Médico solicitante: Dr(a). Zenita Pacheco Moreira Amorim.

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 23:06 hs e finalizado às 06:12 hs. A latência para início do sono foi de 16,9 min e a latência para o sono REM de 152,0 min. O tempo total de sono (TTS) foi de 266,5 min, com eficiência do sono de 62,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 14,1% de estágio N1, 53,1% de estágio N2, 14,6% de estágio N3 e 18,2% de sono REM. O tempo acordado após o início do sono foi de 141,8 min.

Ocorreram 106 despertares, sendo o índice de 23,9 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros foi de 63,3 (nº/h), sendo 1,1 (nº/h) associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 48, sendo 2 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 46 hipopneias e 0 "RERAs".

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 10,8 (nº/h). O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 10,8 (nº/h).

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) basal foi de 92,2%, a média de 91,6% e a mínima de 84,0%. O índice de dessaturação foi de 14,6(nº/h) durante o sono. Permaneceu 7,5% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA

Conclusão:

Aumento leve do índice de apneia e hipopneia, às custas principalmente de eventos obstrutivos.

Dessaturação da oxi-hemoglobina.

Registro de ronco leve.

Aumento de despertares.

Redução da eficiência do sono, às custas de aumento do tempo em vigília após o adormecer.

Redução do sono de ondas lentas e do sono REM.

Aumento dos movimentos periódicos dos membros inferiores durante o sono.

Dra. Anna Karla Smith

CRM: 77842

EDEGARD DE SA AMORIM

Rua Marselhesa, 500 | Vila Clementino | São Paulo - SP | Brasil
CEP 04020-060 | www.sono.org.br